جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هدى رجب وهيب حميده
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** حلوان **العنوان :** مممممممممم
رقم البطاقة : 28305010110646 **رقم التليفون :** 01553060492 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-05-1983 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة الإجابات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هدى رجب وهيب حميده
National ID: 28305010110646

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

كود المستشفى: 102233

وزارة الصحة و السكان
الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة
جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

فاتورة علاج رقم ٢٢٨٤٧٧٢٨

تقر مستشفى جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * بأن أصول مستندات الصرف ومؤيداتها القانونية صحيحة وعلى مسئوليتنا.
وتم حفظها بغرفة الحفظ لدينا وتحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات واننا لم ولن نتقدم بتلك الفاتورة لأي جهة اخرى للصرف.

اسم المريض هدى رجب وهيب حميده الرقم القومي ٢٨٣٠٥٠١٠١١٠٦٤٦
قرار وزاري رقم ٢٠٢٦٤١٠٦٥٠٧٨ بتاريخ ٢٠٢٦-٠٩-٠٧ بمبلغ ٣٠٠٠ مدة القرار ٩٠ يوم
تاريخ الفاتورة ٢٠٢٦-٠٩-١٠ التشخيص سرطان بالثدي (مبادرة)
الإجراء علاج تدعيمي وتلطيفي ودوائي وابحاث الخصم (%) ٠

مدين	بيان	كمية	وحدة	تاريخ الصرف	ملاحظات
١٠٨	Ceftriaxone 1 gm with Local Anesthetic Solvent I.M.	2	vial	08/09/2026	
٤٨	Pantoprazole 40mg	1	ampoule	08/09/2026	
٤٦	NORMAL SALINE 0.9% 100ml	2	bottel	08/09/2026	
٤.١٥	Vitamin B containing At Least (B1, B6, B12)	1	ampoule	08/09/2026	
٣٣	Glucose 10 % Solution	1	Bottle 500 ml WITH rubber cap	08/09/2026	
٢٧	Normal Saline 0.9 % Solution	1	Bottle 500 ml WITH rubber cap	08/09/2026	
٦.٧٠	Ipratropium bromide 500mcg/2ml	1	unit dose vial 2 ml	08/09/2026	
٢٤	Budesonide 0.5 mg/ ml	1	Vial for Nebuliser suspension	08/09/2026	

	08/09/2026	AMP / 2 ML	1	Dexamethasone sod. PO4 8mg	٦.٧٠
	08/09/2026	Bottle 500 ml with out rubber cap	1	Mannitol 20%	٥٤
	08/09/2026	Tablet/Capsule	1	levetiracetam	٢٥
	08/09/2026	unit dose vial 2 ml	1	Ipratropium bromide 500mcg/2ml	٦.٧٠
	08/09/2026	bottle	2	levetiracetam	٣٠
	08/09/2026	Bottle 500 ml with out rubber cap	1	Mannitol 20%	٥٤
	08/09/2026	AMP / 2 ML	1	Dexamethasone sod. PO4 8mg	٦.٧٠
	08/09/2026	Vial for Nebuliser suspension	1	Budesonide 0.5 mg/ ml	٢٤
	09/09/2026	bottle	1	levetiracetam	١٥.٧٠
	09/09/2026	bottel	1	NORMAL SALINE 0.9% 100ml	٢١.٧٠
	09/09/2026	Bottle 500 ml with out rubber cap	1	Mannitol 20%	٥٣
	09/09/2026	AMP / 2 ML	2	Dexamethasone sod. PO4 8mg	١٢.٦٠
	09/09/2026	Bottle 250 ml	1	Normal Saline 0.9% Solution	٢١.٧٠
	09/09/2026	Vial for Nebuliser suspension	1	Budesonide 0.5 mg/ ml	٢٤.٠٨
	09/09/2026	vial	2	Ceftriaxone 1 gm with Local .Anesthetic Solvent I.M	٩٨.٢٢
	09/09/2026	Bottle 500 ml WITH rubber cap	1	Glucose 10 % Solution	٣٢.٠٦
	09/09/2026	unit dose vial 2 ml	1	Ipratropium bromide 500mcg/2ml	٦.٨٠
	10/09/2026	ampoule	1	Pantoprazole 40mg	٦٨.٥٠
	10/09/2026	Bottle 500 ml WITH rubber cap	1	Glucose 10 % Solution	٣٢.٠٦
	10/09/2026	Bottle 500 ml WITH rubber cap	1	Normal Saline 0.9 % Solution	٢٨
	08/09/2026		1	سي ا ربي	١٢٠
	08/09/2026		1	ايه اس تي	٧٠
	08/09/2026		1	كالسيوم متاين	١٦٠
	08/09/2026		1	بوتاسيوم	١١٠
	08/09/2026		1	صوديوم	١١٠
	08/09/2026		1	ايه ا ل تي	٧٠
	08/09/2026		1	صورة دم كاملة	١٥٠
	08/09/2026		1	غازات بالدم	٣٥٠

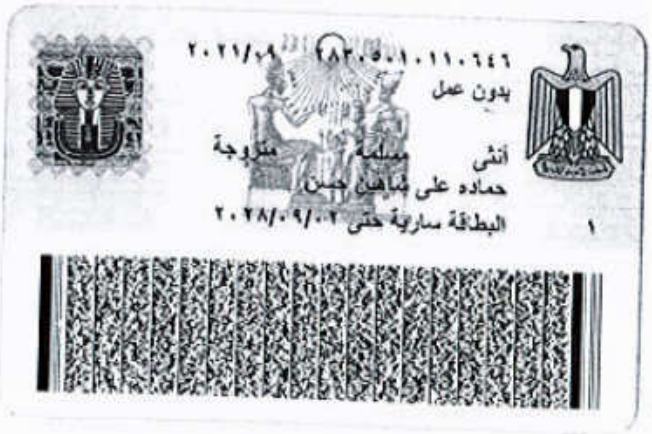
١٥٠	زمن البروثرومبين	1		08/09/2026	
٧٠	بيليروبين كلي	1		08/09/2026	
٧٠	بيليروبين مباشر	1		08/09/2026	
٧٠	بولينا	1		08/09/2026	
٧٠	كرياتنين	1		08/09/2026	
١١٠	بوتاسيوم	1		09/09/2026	
١٥٠	صورة دم كاملة	1		09/09/2026	
٧٠	بولينا	1		09/09/2026	
٧٠	كرياتنين	1		09/09/2026	
١١٠	صوديوم	1		09/09/2026	
٢٩٩٨.٣٧	الاجمالـــــــي				

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الموظف المختص	المراجع	رئيس حسابات المرضى	مدير الشئون المالية
عبدالله محمود	ساره السيد	فاروق ناجي	







National ID - Front&Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECIION SUPPORT

جهه الاصدار :فرع القاهرة

تاريخ الاصدار :4-10-2022

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) هدى رجب وهيب حميده بطاقة رقم 28305010110646

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى

وشكرا

تاريخ الطباعه :4-10-2022

الموظف المختص

رباب عبد المنعم

افادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

مسلسل 166990

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار .

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

Name: هدى رجب وهيب حميده	
MR. : 3263	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 43-year-old premenopausal individual with a history of left breast cancer treated with neoadjuvant chemotherapy, followed by an axillary clearance and four cycles of adjuvant therapy in November 2021, then left modified radical mastectomy with pathology ypT1, ypN0. Subsequent adjuvant therapy included femara and zoladex, 12 cycles of Kadcyla completed in October 2022, and metastatic treatment to brain and lung with eight cycles of taxol, aromasin, and continued trastuzumab (15 cycles completed in December 2025). No further trastuzumab approval has been obtained; the patient has been maintained on zoladex and aromasin since January 2026. In August 2026 the patient developed new left-sided hemiparesis; MRI of the brain demonstrated a right parietal solitary lesion measuring 41 × 32 mm with mass effect and contralateral shift, requiring a one-week ICU admission. A CT scan performed in August 2026 was unremarkable.

The tumor is estrogen-receptor positive (ER 8/8), progesterone-receptor positive (PR 8/8), and HER2-positive (3+). Imaging confirmed metastatic disease to the brain and lung, with the recent brain MRI showing the described right parietal lesion. No additional metastatic sites were identified on the CT scan.

The referring team recommended continuation of systemic therapy and consideration of local control for the brain metastasis. The multidisciplinary team agreed to proceed with the proposed plan, maintaining current endocrine therapy (zoladex and aromasin) and evaluating options for targeted treatment of the brain lesion.

تحريرا في ,

التاريخ : 23-09-2026 الوقت :

الطبيب المعالج :

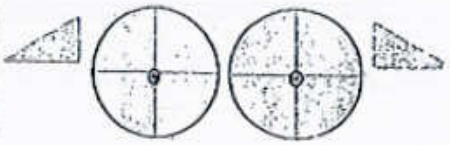
يعتمد ,

[[DOCTYPE:OTHER_DETAILED_MEDICAL_REPORT]]

Ministry of Health and Population وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : هدى رجب و قلب حميده Sex: Female
3- Medical number: 83040092 Old Med : 1476-2021
2-ID number:
Patient Age : 41 Y



Family history	Family History	Phone	Phone	01274566856	BMI	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT	
marital status	Marital Status	NRS Score	NRS Score		GROUP	GROUP M	Date of MDT	Date Of MDT	17/11/2024
Co morbidity	Co morbidity	Menopausal status	Menopausal Status		Initial STAGE	Initial STAGE			

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC	8/8	8/8	3		45
BX COMMENT:	ER COMMENT:	PR COMMENT:	Her 2 Neu COMMENT:	SISH COMMENT :	

T	N	M
		1 brain and lung

Sonomammography

PATIENT HISTORY

PT WAS DIAGNOSED WITH LT MULTICENTRIC BREAST cancer
received NACT AC x4+THP x4 -->SSM no PCR
followed by TDM +AI
new MRI--> sol ,,new work up : lung metastasis
Recived WBI
for taxol trastuzumab IV for 2 years > stable disease

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN
for AI & CONTINUE trastuzumab (E2 level 11 for FU)

Aromasin

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ هشام عزت د/ زينب صبره	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ شريف سابع
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذه / هدى رجب وهيب حميده	Request No.	: 13005793
Patient No.	: 28305010110646	Request Date	: 17/08/2022
Path No.	: 2372/22	Verification Date	: 23/08/2022
Sex	: Female	Financial Category	: ام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 39 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast mass.

Nature of the specimen:
Tru-Cut biopsy (received at 17/08/22).

Gross Examination:
* greyish white tissue cores, up to 1.5cm long. Totally submitted.

Microscopic examination:
Histological type: Fat necrosis.
Additional pathologic findings: No.

Diagnosis:
Left breast mass; Tru-Cut biopsy:
Fat necrosis.

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Abdulrahman Ibrahim

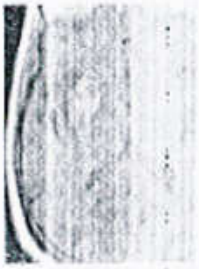
Verified by :
abdelrahman ibrahim

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Name : hoda ragab waheb	**Date : 31-12-2025 01:07**
Branch : Portable	**Medical No. : GRI-28305010110646**
Ref.Physician Prof :	**Ins.Company :**



OPEN MRI OF THE BRAIN

TECHNIQUE:-

Axial T1, T2, FLAIR, DWI & ADC
Coronal T2 WIs
Sagittal T1 WIs
Post contrast T1 WIs

FINDINGS:-



- A well-defined right fronto-temporal intra-axial space occupying lesion is seen deep to the sylvian fissure measuring about 3.6 x 2.5 x 3 cm in its maximal axial and CC dimensions. It elicits mixed low and isointense signal T1, mixed high T2 signal with heterogenous post contrast enhancement and cystic components with no evidence of diffusion restriction. It's seen surrounded by moderate grade II perifocal brain edema together with the lesion exerting mass effect in the form effacement of the related cortical sulci and compression on the right lateral ventricle with minimal midline shift.
- Few left cerebral periventricular white matter areas of high T2 and FLAIR signal intensity are seen exerting no mass effect on the surrounding structures with facilitated diffusion possibly denoting chronic white matter ischemia.
- Otherwise normal appearance of the ventricular system.
- No extra-axial collections.
- Normal appearance of the cerebellum and brain stem.
- Non definite calvarial bone lesions.

OPINION:

Right fronto-temporal intra-axial SOL as described, likely neoplastic for correlation with unavailable clinical data.

Much Obliged;
Dr.Marwa Elgawish, MSc, FEBR

M.R.I
[[DOCTYPE:MRI]]

وزارة الصحة
إدارة المراكز الطبية التخصصية
مستشفى معهد ناصر
Nasser Institute Hospital

Oncology Center مركز الأورام

NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER

NUCLEAR MEDICINE UNIT

وحدة الطب النووي

Patient Name: Hoda Kamal Ghali
Referring Physician: Prof. [illegible]

Date: 22/5/2021

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

- Warm uptake at left 8th rib anterior end likely traumatic for X-RAY correlation and follow up.
- Degenrative changes at the dorsal and lumbar vertebrae.
- Otherwise the rest of surveyed skeleton is free from serious bone lesions.
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.
Follow up bone scan and X-ray left 8th rib anteriorly is advised.

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit
Huda Fathy, M.D
Magdy Kotb, M.D.

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Health Insurance Organization
Nasr City Cancer Center
(NCCC)

الهيئة العامة للتأمين الصحي
مركز أورام مدينة نصر

اسم المريض : هدى رجب وهيب

تاريخ الخدمة :25/3/2021

Immunohistochemistry report

Lab-No.:21/187

-Procedure:

-Sections immunostained for ER, PR, Ki67 and Her2neu using supersensitive monoclonal antibodies with Roche envision (Dextran substrate polymer) flex detection system. Pretreatment for heat induced epitope retrieval (HIER) was performed using flex target retrieval solution. Blocking of endogenous peroxidase was performed using Roche peroxidase blocking reagent DAB was used as a chromo

Results:

ER: (8/8).

PR: (8/8).

Her2:Score=3 , positive

KI67:45%

N.B: The slides are delivered to the patien..

Prof.Dr.Hussain El Sayed

Immunohistochemistry
][DOCTYPE IMMUNOLOGY]]

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

09/20/2026

MDT FORM

Name:	Hoda RAGAB Wahib Hamida	**MRN:**	3263
Age:	43 Y	**ID:**	28305010110646
Menopausal Sta	prem	**Phone:***	01142017457
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
Gender			
CO Morbidity:		**Reason Of MDT:**	dp
Surgical History:*	left mrm	**ECOG Performance Status**	○ 0 ○ 1 ○ 2 ◉ 3 ○ 4

Clinical Data:

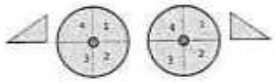
BX:

ER: **PR:** **HER2:** **KI67:**

History:

PREMENOPAUSAL MBC TO BRAIN ,LUNG ER8/8 PR 8/8 HER2 3+
HISTORY :
LEFT BREAST CANCER REC NACT AC 4 THP ON 11/2021 LEFT MRM YPT1 UPN0 REC FEMARA AND ZOLADEX ,12 KADCYLA LAST 10-2022 ,
ON 11-2023 METS TO BRAIN,LUNG REC 8 CYCLES TAXOL ST AROMASIN FROM 1/2025 and continued herceptin rec 15 cycles last 12/2025
no more approval of herceptin since then
pt continued zoladex aromasin only from 1/2026
8/2026 newly developped left sided hemiparesis
mri brain rt parietal sol m 41x32 with mass effect with contralat shift pt was admitted in icu for 1 week
cts 8/2026 free
for mdt

R L



T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

Pathological Staging:

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

REVISION OF RADIOTHERAPY OF THEBRAIN TIME AND DOSE IF NOT RECEIVE BEFOR WCI
TYKERB/XELOD 4 MOTHS THEN EVALUATION

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د محمد كيلاني	د محمد نيراوي		

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

جوستاف روسي انترناشونال

ECHO REPORT

NAME: [illegible] DATE: 4 /3 /2026

ID NUMBER: 1476 /21 SEX: ♀ AGE: 42

EF	62%	55-75%	PWT	0.7	0.6-1.1cm
LVEDD	4.6	3.5-5.8cm	AO.R	2.1	3-3.7cm
LVESD	2.3	2-4cm	LA	3.6	2-4cm
FS	30%	25-45%	RV		0.7-2.3com(supine)
SWT	0.8	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV Dimensions Normal

LV Wall Thickness Normal

LV Diastolic Function Normal

SWMA No RWMA

LA and Ao Root Dimensions Normal

Mitral Valve N

Aortic Valve

Tricuspid Valve N

Pulmonary Valve

Right Side and Systolic Function TAPSE: 2.1

Intracardiac Masses and Effusion

DR. [illegible]

Patient's Name:	**Huda Ragab Waheb Hamida**
Date:	**2026-08-26**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

Examination:

■ Computed tomography of the chest, abdomen and pelvis

Technical data:

- 5 mm CT scans of the abdomen and pelvis with IV contrast

Clinical data: known case of left breast cancer underwent MRM on treatment.

Comparison: none

Findings:

- **Chest findings:**
- Left breast operative bed / scar region chest wall heterogeneous mixed density lesion 5x3 cm (mixed soft tissue, fat and calcifications)
- Left clavicle small single sclerotic focus
- Left upper lung lobe subpleural fibrotic changes likely post radiation sequel
- Clear rest lungs fields with no active parenchymatous infiltrates.
- No hilar or mediastinal masses or sizable LNs.
- Normal appearance of the tracheobronchial tree.
- No evidence of pleural effusion or thickening.
- Average cardiac size, no pericardial effusion.
- **Abdomen and pelvis findings:**
- The liver shows mildly enlarged size with smooth contours, homogeneous hepatic parenchyma density, and no evidence of focal lesions.
- No intra hepatic biliary dilatation.
- Normal caliber and homogenous enhancement of the portal vein.
- The spleen shows normal size. No evidence of focal lesions.
- Normal CT appearance of the gall bladder, pancreas and adrenal glands
- Both kidneys are of normal site, size and shape, no stones, back pressure, cysts or masses bilaterally.
- The urinary bladder shows average distention, no wall thickening, no stones, diverticulae or masses.
- No suspicious abdominal or pelvis enlarged LNs
- No CT evidence of intestinal obstruction

جوستاف روسي

Patient's Name:	**Huda Ragab Waheb Hamida**
Date:	**2026-08-26**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

- No pneumoperitoneum
- No free or localized abdominal or pelvis fluid collection
- Small umbilical hernia admitting fat.

Opinion:

- **Left breast operative bed / scar region chest wall heterogeneous mixed density lesion 5x3 cm (mixed soft tissue, fat and calcifications)**
- **Left clavicle small single sclerotic focus**
- **No definite pulmonary nodules or masses**
- **No suspicious abdominal or pelvis metastatic lesions on CT base**

Recommendation:

- **PET-CT correlation**

Regards, Dr. Ahmed Rezk, MD.

Ahmed

Ahmed

Patient's Name:	**Hoda ragab wahib hemida**
Date:	**2026-04-15**
Referred by:	Prof.Dr. cap+c
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used.

FINDINGS:

Status post left MRM for known case of CA breast. Compared to the last study dated 16-4-2025 ,the current study showed:

(I) Chest:

- Left upper lobar apical reticulations of post old inflammatory sequelae.
- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.
- Left mastectomy bed calcified focal fat necrosis.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density with no focal lesions.
- Patent and homogenously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.

جوستاف روسي

Patient's Name:	Huda Rag ida
Date:	2026-09-06
Referred by:	Prof.Dr. no doctor
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

Clinical data: known case of left breast cancer underwent MRM on treatment.
Comparison: august 2026 study comparison.
Findings:

- **Chest findings:**
- Still noted Left breast operative bed / scar region chest wall heterogeneous mixed density lesion 5x3 cm (mixed soft tissue, fat and calcifications)
- Left clavicle small single sclerotic focus less than 850 HU (insiginifacnt)
- Left upper lung lobe subpleural fibrotic changes likely post radiation sequel.
  Small right lower lobe subpleural nodule 4x2.3 mm.
- Clear rest lungs fields with no active parenchymatous infiltrates.
- No hilar or mediastinal masses or sizable LNs.
- Normal appearance of the tracheobronchial tree.
- No evidence of pleural effusion or thickening.

Average cardiac size, no pericardial effusion.

CONCLUSION :
stationary course as regard last study august 2026.

Subcentimetric right lower lobe nodule(noted in last study with same size). Follow up is recommended

DR Nada

Request Inquiry - GTS.Presentatio × New tab
RjLWE0YTdlZjQ4LTdmNjliZWE0LTk3ZTZiYjc0LTA3MTBmM2E0LzllOGU5NjNmLTQ0YTBjOTNmLTIwNTIxOWU2L

Study Notes

Patient's Name:	Huda R amida
Date:	2026-09-09
Referred by:	Prof Dr. no doctor
Hospital:	Goustave Roussey International Egypt

MRI OF THE BRAIN

Technique :

Axial T1, T2 ,FLAIR,
Coronal T2
Sagittal T1
Postcontrast T1

Findings:

- Right parietal intra axial SOL is seen measuring 41 x 32 x mm in maximum dimensions eliciting heterogenous low T1 WI signal, bright T2 WI and heterogenous bright FLAIR WI signal with cystic components seen. It shows heterogenous contrast uptake. Surrounding edema is seen, together they are seen causing mass effect in the form of compression of the adjacent lateral ventricle and effacement of the adjacent cortical sulci. The lesion is seen causing mild midline shift to the contralateral side.
- Few bilateral cerebral periventricular foci of abnormal MR signal are seen displaying low signal on T1 that turned bright on T2 & FLAIR with no evidence of contrast uptake. No mass effect or perifocal oedema.
- Mild dilatation of the supra and infra tentorial ventricular system. Bright T2 & FLAIR signal are seen framing the periventricular white matter.
- Prominent cortical sulci and extra axial CSF spaces.
- No extra axial collections.
- No cerebello pontine angle masses.
- No gross posterior fossa abnormalities.

OPINION:

- ***Right parietal intra axial SOL ? metastatic for MR spectroscopy.***
- ***Few bilateral cerebral lacunar infarctions.***
- ***Diffuse subcortical arteriolo-sclerotic leukoencephalopathy.***
- ***Involutional brain changes.***

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

جوستاف روسي انترناشونال

ECHO REPORT

NAME: [illegible] DATE: 4 /3 /2026

ID NUMBER: 1476 /21 SEX: ♀ AGE: 42

EF	62%	55-75%	PWT	0.7	0.6-1.1cm
LVEDD	4.6	3.5-5.8cm	AO.R	2.1	3-3.7cm
LVESD	2.3	2-4cm	LA	3.6	2-4cm
FS	30%	25-45%	RV		0.7-2.3com(supine)
SWT	0.8	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV Dimensions Normal

LV Wall Thickness Normal

LV Diastolic Function Normal

SWMA No RWMA

LA and Ao Root Dimensions Normal

Mitral Valve N

Aortic Valve

Tricuspid Valve N

Pulmonary Valve

Right Side and Systolic Function TAPSE: 2.1

Intracardiac Masses and Effusion

DR. [illegible]